

CAPÍTULO 10.12

Enfermedades de Transmisión Sexual – Primera Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) — Parte I

Generalidades

- **Prevención:** Educación sexual + Uso de preservativo + Disminuir promiscuidad (> 2 parejas/año). - **Vacunas:** VPH (serotipos 6, 11, 16, 18) + Hepatitis B. - **Regla de oro:** Tener una ETS = máximo riesgo de tener otra → **Siempre estudiar el resto** al diagnosticar una.

Uretritis

Clínica: Secreción uretral + disuria (± adenopatías inguinales). En mujeres puede ser asintomática (portadoras) o complicarse con EIP, embarazo ectópico, cervicitis.

Diagnóstico diferencial: Gonocócica vs. No Gonocócica

TABLA 10.12.1: TIPO VS AGENTE

TIPO	AGENTE	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
Gonocócica	<i>N. gonorrhoeae</i>	Gram directo (coco Gram -) — En hombre. Cultivo (Tyler Martin) — En mujer	Ceftriaxona 250 mg IM × 1 + cobertura para Clamidia
No Gonocócica	<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma</i> , <i>Ureaplasma</i>	PCR o cultivo	Doxiciclina 100 mg c/12h × 10 días (o Azitromicina 1 g × 1)

EUNACOM CRITERIOS

Si es gonocócica → siempre agregar cobertura para Clamidia simultáneamente (co infección frecuente).

Herpes Genital

- **Agente:** Herpes simplex tipo 2 (principalmente) y tipo 1.
- **Clínica:** Vesículas múltiples → úlceras dolorosas en genitales, zona glútea o sacra.
- **Diagnóstico:** Clínico. Confirmación con PCR HSV-1/2 si hay duda.
- **Tratamiento:**
 - - Aciclovir 400 mg VO × 5 veces/día × 7 días
 - - **Valaciclovir 500 mg VO × 3 veces/día × 7 días** (más cómodo, de preferencia)
- **Herpes en parto:** Herpes activo con lesiones visibles al momento del parto → **Cesárea obligatoria** (riesgo de herpes neonatal grave).

Condiloma Acuminado (Verrugas Genitales)

- **Agente:** VPH serotipos 6 y 11.

- **Clínica:** Lesiones polipoideas, indoloras, de crecimiento lento. Ubicación: surco balano-prepucial, meato urinario, labios menores, zona perianal (en sexo anal).
- **Diagnóstico:** Clínico.
- **Tratamiento:** Local (cualquier método es aceptable):
 - - Crioterapia (más habitual), Ácido tricloroacético, Imiquimod, Podofilino, Resección quirúrgica.
- **Parto:** Condiloma pequeño → **No contraindica parto vaginal**. Solo contraindica si es muy grande (tumor previo obstructivo).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 28 años consulta por disuria y secreción uretral purulenta. Se realiza tinción de Gram que muestra cocáceas gramnegativas intracelulares. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades de Transmisión Sexual - Primera Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Prevención de ETS: educación sexual, disminuir promiscuidad (>2 parejas/año), uso de preservativo. Tener una ETS = máximo riesgo de otra.
- Uretritis gonocócica: ceftriaxona 250 mg IM + cobertura para clamidia. Gram en hombres; PCR o cultivo Thayer-Martin en mujeres.
- Uretritis no gonocócica (*Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Ureaplasma*): doxiciclina 100 mg c/12h por 10 días o azitromicina 1 g por una vez.
- Herpes genital (VHS-2 principalmente): vesículas/úlceras múltiples. Aciclovir 400 mg x5/día o valaciclovir 500 mg c/8h, por 5-7 días.
- Herpes activo al momento del parto = contraindicación ABSOLUTA de parto vaginal (riesgo herpes neonatal).
- Condiloma acuminado (VPH 6 y 11): lesiones polipoideas indoloras, diagnóstico clínico, tratamiento local (crioterapia de elección). NO contraindica parto vaginal salvo tumor previo.
- Vacuna VPH: serotipos 6,11 (condiloma) y 16,18 (cáncer). Vacuna hepatitis B en hexavalente.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - PRIMERA PARTE)

PREGUNTA 1

Hombre de 28 años consulta por disuria y secreción uretral purulenta. Se realiza tinción de Gram que muestra cocáceas gramnegativas intracelulares. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A) Ceftriaxona 250 mg IM por una vez
- B) Doxiciclina 100 mg c/12h por 10 días solamente
- C) Ceftriaxona 250 mg IM más doxiciclina 100 mg c/12h por 10 días
- D) Ciprofloxacino 500 mg oral por 7 días
- E) Metronidazol 500 mg c/8h por 7 días

PREGUNTA 2

Mujer de 32 semanas de embarazo en trabajo de parto. Al examen genital se observan vesículas activas en labio menor derecho. ¿Cuál es la conducta obstétrica más adecuada?

- A) Parto vaginal con precauciones de barrera
- B) Iniciar aciclovir endovenoso y reevaluar en 24 horas
- C) Cesárea
- D) Parto vaginal, ya que el herpes genital no contraindica la vía vaginal
- E) Esperar resolución espontánea de las vesículas para parto vaginal

PREGUNTA 3

Paciente de 22 años consulta por lesiones polipoideas indoloras en surco balanoprepucial de crecimiento lento. ¿Cuál es la conducta más importante además del tratamiento local?

- A) Realizar biopsia de las lesiones para confirmar diagnóstico
- B) Solicitar PCR para VPH y tipificación viral
- C) Descartar otras ETS (VIH, gonorrea, sífilis, clamidia)
- D) Iniciar tratamiento antiviral con aciclovir
- E) Derivar a cirugía para resección quirúrgica amplia

RESUMEN: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - PRIMERA PARTE

Esta clase aborda las generalidades de las ETS y cubre uretritis, herpes genital y condiloma acuminado. Las medidas preventivas fundamentales son la educación sexual, disminuir la promiscuidad sexual (definida como más de 2 parejas al año) y el uso de preservativo. Tener una ETS confiere el máximo riesgo de tener otra, por lo que siempre hay que descartar las demás. Las uretritis se diagnostican clínicamente (disuria, secreción uretral, adenopatías inguinales). En hombres el diagnóstico etiológico es con Gram; en mujeres con PCR o cultivo de Thayer-Martin. La uretritis gonocócica se trata con ceftriaxona 250 mg IM más cobertura para clamidia. La uretritis no gonocócica (*Mycoplasma*, *Ureaplasma*, *Chlamydia*) se trata con doxiciclina 100 mg c/12h por 10 días o azitromicina 1 g por una vez. El herpes genital es causado principalmente por VHS tipo 2, con diagnóstico clínico (vesículas y úlceras múltiples). Se trata con aciclovir 400 mg 5 veces/día o valaciclovir 500 mg c/8h por 5-7 días. El herpes activo al momento del parto contraindica absolutamente el parto vaginal. El condiloma acuminado es por VPH serotipos 6 y 11, con diagnóstico clínico (lesiones polipoideas indoloras). El tratamiento es local (crioterapia, ácido tricloroacético, imiquimod, podofilino). No contraindica parto vaginal salvo que sea muy grande.